

Недержание кала (Fecal Incontinence)

WARWIKI

Информация для пациента · Потеря контроля над газами или стулом — это часто встречается и поддаётся лечению

Недержание кала — это непроизвольное выделение газов или стула: утечка до того, как вы успели добраться до туалета, или незаметно для вас. Это встречается гораздо чаще, чем принято думать, особенно после родов или с возрастом, и хорошо поддаётся лечению. Не стоит стесняться — сообщить своему врачу об этой проблеме и есть первый шаг к её решению.

Об этом состоянии

Удержание стула зависит от **мышц анального сфинктера**, тазового дна, консистенции стула и нервов, которые их координируют. Проблема с любым из этих компонентов может вызвать недержание — от пятен и газов до потери оформленного стула.

Причины

- **Травма сфинктера** — чаще всего после родов (тяжёлый разрыв) или операций на анусе
- **Жидкий стул или диарея** — удержать труднее, чем оформленный стул
- **Тяжёлый запор** с жидким стулом, просачивающимся вокруг твёрдых масс
- **Нервные нарушения**, выпадение прямой кишки или синдром раздражённого кишечника

Нередко причин несколько, и на многие из них можно повлиять.

ТЕРМИНЫ

Fecal incontinence

Непроизвольное выделение газов или стула.

Анальный сфинктер

Кольцо мышц, удерживающее стул до момента дефекации.

OASIS

Тяжёлый (3-й/4-й степени) родовой разрыв с повреждением сфинктера.

Клетчатка (клетчатка/Fiber)

Пищевое волокно, которое уплотняет жидкий стул и уменьшает вытекание.

Биологическая обратная связь (Biofeedback)

Терапия для переобучения мышц тазового дна и сфинктера.

Сакральная нейромодуляция

Метод стимуляции нервов, улучшающий контроль стула.

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ? Да — большинство пациентов значительно улучшают контроль, нередко с помощью простых мер: уплотнения стула и тренировки мышц. При необходимости эффективно применяются более серьёзные методы. Самое сложное — заговорить об этом; как только вы это сделаете, появится чёткий путь к улучшению.

Как это диагностируют

- Сбор анамнеза: как часто, в каком объёме и что провоцирует недержание
- Осмотр анального сфинктера и тазового дна
- При необходимости — УЗИ сфинктера, аноректальные тесты или эндоскопия

Как это лечат (поэтапно)

- 1 Нормализация стула** — добавить клетчатку для уплотнения, устранить диарею или запор, наладить регулярный режим дефекации.
- 2 Физиотерапия тазового дна / biofeedback** для укрепления и координации мышц.
- 3 Лекарства** (например, противодиарейные) при жидком стуле.
- 4 Расширенные методы** — сакральная нейромодуляция, инъекционный наполнитель или пластика сфинктера.

Жизнь с этим состоянием

- Стремитесь к **оформленному стулу** с помощью клетчатки и достаточного питья.
- Опорожняйтесь в одно и то же время; берегите кожу и носите с собой необходимые принадлежности.
- Отслеживайте, какие продукты усиливают недержание (кофеин, острое, сахарозаменители).

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Кровь в стуле** или чёрный дёгтеобразный стул
- Новое или резкое изменение характера стула, необъяснимая потеря веса
- Повышение температуры или сильные боли в животе

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

- 1.** Недержание кала — распространённая проблема, поддающаяся лечению: не нужно терпеть или молчать о ней.
- 2.** Лечение начинается с уплотнения стула и тренировки мышц, при необходимости переходя к нейростимуляции или пластике.
- 3.** Сообщите врачу — это ключевой шаг. Обязательно расскажите о крови в стуле, потере веса или резком изменении характера стула.